

POLIARTRITIS

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Poliartritis: en un sentido estricto sería, la sinovitis de ≥ 4 articulaciones. **Oligoartritis:** en caso de afectación de 2 o 3 articulaciones. Sin embargo, esta clasificación tiene poca relevancia clínica, por lo que podríamos considerar poliartritis a partir de 2 articulaciones afectas. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica diaria.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

- Historia familiar.
- Edad y sexo: Algunos ejemplos.
 - Varones jóvenes: Espondiloartropatía.
 - Mujeres jóvenes: Conectivopatías y artritis víricas.
 - Mujeres mediana edad: Artritis reumatoide.
 - Mayores 60 años: Polimialgia reumática.
- Antecedentes inmediatos: Infecciones recientes, contactos sexuales, diarrea...
- Inicio y evolución clínico:
 - Aguda: Duración de menos de 6 semanas, suele orientar a proceso infeccioso o por microcristales.
 - Crónica: Duración de más 6 semanas, orienta a proceso autoinmune o cuadros neoplásicos.
 - Distribución:

SIMÉTRICA	ASIMÉTRICA
• Artritis reumatoide (AR)	• Espondiloartropatías.
• Artrosis.	• Artropatía por ácido úrico-pirofosfato cálcico.
• Artritis vírica.	• Artritis bacteriana. Enfermedad de Lyme. Endocarditis bacteriana.
• LES/Polimialgia reumática/ Enfermedad mixta de tejido conectivo.	• Reumatismo palindrómico.
• Osteoartropatía hipertófica.	• Síndromes paraneoplásicos.

- Secuencia afectación articular: Aditivo: Afectación de nuevas articulaciones con anteriores afectas. Migratorio: Afectación de nuevas articulaciones y anteriores con mejoría intermitente: Remisión completa entre los episodios. Localización manos y pies: metacarpofalángicas: AR. - Primer dedo de pie: Artritis gotosa. Interfalángica proximal: AR/ Nódulos de Bouchard de artrosis Interfalángica distal: Artritis psoriásica/ Nódulos de Heberden de artrosis. Carpos: AR. Caderas, artritis en miembros inferiores: Espondiloartropatías.

- Exploración sistémica.

Pruebas complementarias

- Artrocentesis: con análisis del líquido articular valorando aspecto macroscópico, bioquímica, recuento y fórmula leucocitaria y búsqueda de cristales. (Ver capítulo monoartritis).

- Hemograma.
- Coagulación
- Bioquímica básica con reactantes de fase aguda PCR, VSG, procalcitonina y niveles de ácido úrico.
- Sistemático y sedimento de orina y urocultivo
- Hemocultivos si fiebre.
- Analítica con serologías o marcadores de autoinmunidad (ANA, ENA, ACA, Anticuerpos lúpico, proteinograma, C3 y C4) para detectar las etiologías infecciosa y reumática. CK, factor reumatoideo, anticuerpos antipéptido citrunilado.
- Pruebas de imagen: Radiología simple.
 - Artrosis: Osteofitos, esclerosis subcondral, disminución de espacio articular...
 - Artritis reumatoide: Erosiones.
 - Artropatías microcristalinas: Calcificaciones de cartílago y partes blandas (Pirofosfato cálcico, hidroxipatita). Erosiones en sacabocado (Ácido úrico).

Criterios de ingreso

- Mal estado general del paciente con limitación funcional importante.
- Sospecha de artritis séptica: Raro.
- Sospecha de enfermedad sistémica.

TRATAMIENTO

- Medidas generales: Reposo relativo de la articulación.
- Corticoides a dosis 15 -20 mg/día cada 12h durante 3-5 días, si tratamiento es de larga duración incluir al tratamiento calcio y vitamina D
- Según causa:
 - Séptica: ingreso y antibioterapia dirigida.
 - Microcristalina: no modificar ni iniciar pauta hipouricemiante.
 - Analgésicos: Metamizol 575 mg c/6-8h.
 - Antiinflamatorios. Naproxeno 500 mg 1c/12 h o Ibuprofeno 600 mg c/8h o Celecoxib 100 - 200mg cada 24h o Etoricoxib 60, 90 o 120mg cada 24horas. Se asociara HBP como: omeprazol 20 o 40mg cada 24h o pantoprazol 20 o 40mg cada 24h.
 - Colchicina 1 mg cada 24 horas.
 - Procesos reumatológicos (AR/ EA): AINE (Naproxeno 500 mg c/12h) y derivación a consultas de reumatología si buen estado general.
 - Sospecha de proceso sistémico no filiada: ingreso para estudio.

NOTA

- Muchas enfermedades reumatológicas pueden presentarse como poliartritis.

BIBLIOGRAFÍA

- Gómez Centeno A. Poliartritis. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 20: 109-115.
- Zalba Marcos S. Poliartritis aguda. Libro electrónico de Temas de Urgencias. Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Urgencias HVC.
- Jiménez Murillo L., Muñoz Ávila J., Aparicio Sánchez J., Caracue Ruíz M.A., Collantes Estévez

E. Poliartritis. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5 Edición. 2015. 107: 592-594.